

Pięć kroków *według Y-BOCS*

ERP to leczenie pierwszego rzutu ($d = 1,31$). Wybór kroku zależy od nasilenia, nie od preferencji. NICE CG31 jest standardem.

CZAS: 10 min orientacji Na początku procesu leczenia

ŹRÓDŁO: NICE CG31 (2005); Öst i wsp. (2015, meta-analiza); APA (2007); Hirschtritt i wsp. (2017)

JAK UŻYWAĆ

Zorientuj się **na jakim kroku** jesteś. Y-BOCS 8-15 → krok 1-2 (psychoedukacja, samopomoc, krótka CBT). Y-BOCS 16-23 → krok 3 (pełna CBT z ERP **lub** SSRI). Y-BOCS 24+ → krok 4 (CBT + SSRI razem, klomipramina, augmentacja). Ocena co 4 tyg. — spadek $\geq 35\%$ = odpowiedź na leczenie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

NICE CG31 (2005) ustanawia **5-stopniowy model** leczenia OCD. Öst i wsp. (2015, meta-analiza 37 RCT): ERP $d = 1,31$ (duży efekt) vs SSRI $d = 0,48$. ERP jest **leczeniem pierwszej linii**. Wybór kroku zależy od *nasilenia Y-BOCS* (Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale), nie od preferencji pacjenta czy terapeuty. **Bez stepped care:** pacjenci trafiają na *niewłaściwy poziom* interwencji. Łagodne OCD dostaje pełną CBT z ERP (overtreatment, blokowane listy oczekujące); ciężkie dostaje tylko SSRI w dawce depresyjnej (undertreatment — 25-35% redukcji Y-BOCS zamiast możliwych 60%). **40-60% pacjentów z OCD nigdy nie otrzymuje ERP** — wyłącznie leki, mimo że ERP ma **silniejszy efekt**. Kryteria eskalacji oparte na Y-BOCS prowadzą do *właściwej intensywności*.

01

🕒 Pięć kroków NICE

KROK	Y-BOCS	INTERWENCJA
1	8-15	Psychoedukacja + samopomoc (książki, np. Veale i Willson, „Pokonać OCD”). Bez terapeuty.
2	8-15	Krótką CBT z ERP (6-10 h) lub CBT grupowe. Lekkie do umiarkowanego.
3	16-23	Pełna CBT z ERP indywidualnie (16-20 sesji) <i>lub</i> SSRI (fluoksetyna, sertralina, fluwoksamina — <i>wyższe dawki niż w depresji</i>).
4	24+	CBT + SSRI razem , klomipramina, augmentacja antypsychotykiem (aripirazol). Ciężkie/oporne.
5	24+	Intensywne / szpitalne. Programy dzienne, neurostimulacja (TMS, w wybranych przypadkach).

02

💡 Skuteczność — porównanie efektów

ERP (CBT)

 $d = 1,31$ (duży efekt)

SSRI

 $d = 0,48$

ERP ma 2,7× większy efekt niż SSRI. Dlatego NICE rekomenduje ERP jako *leczenie pierwszego rzutu*. SSRI dodaje się przy *ciężkim OCD* (Y-BOCS 24+) lub gdy ERP samodzielnie nie wystarcza.

03 Twoja orientacja

MÓJ WYNIK Y-BOCS

— jeśli znany

KROK, NA KTÓRYM AKTUALNIE JESTEM

— 1–5

AKTUALNE INTERWENCJE

— co teraz

CO JESZCZE MOGŁOBY BYĆ POTRZEBNE

— porównaj z tabelą

04 Kryteria eskalacji

Ocena Y-BOCS co 4 tyg. Spadek $\geq 35\%$ = odpowiedź na leczenie. Mniej = rozważ eskalację.

SSRI dawki w OCD są wyższe niż w depresji (np. fluoksetyna 60–80 mg, sertralina 200 mg, fluwoksamina 250–300 mg).

Decyzja współdzielona z pacjentem. Eskalacja nie jest porażką — to *dostosowanie* do potrzeby.

Czas próby SSRI — minimum 12 tygodni przed oceną skuteczności. Krócej = niewystarczająca próba.

Klucz: Hirschtritt, Bloch i Mathews (2017, *JAMA*): aktualizacja wytycznych — **40–60% pacjentów z OCD nigdy nie otrzymuje ERP**, mimo że jest *najskuteczniejszą* interwencją. Bariery: brak terapeutów przeszkolonych w ERP, długie listy oczekujące, mit „*OCD to choroba chemiczna, leczy się tabletkami*”. Klucz praktyczny: *jeśli aktualnie jesteś tylko na SSRI* i Y-BOCS nie spada, **poproś o ERP**. Połączenie CBT z ERP + SSRI ma *najwyższą* skuteczność w ciężkim OCD (Foa i wsp., 2005). Łącz z *protokołem ERP* i *farmakoterapią* w kompendium.